

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	股骨骨折 Femoral Fracture				
編號	A31000-Q03-W-G01	制定者	N09 陳美如	公布日期	97 年 05 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	114 年 10 月 08 日
版本/總頁數	第 4.0 版/9 頁	審查者	曾翊鍵	檢閱日期	114 年 10 月 08 日

一、目的

護理人員能了解股骨骨折的定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題與措施及衛教指導，有更適切之照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

股骨是大腿的骨骼，是人體中最長的長骨，分為上端、體和下端三部份。可細分為股骨頭、股骨頸、大轉子、小轉子、股骨幹等部位；股骨頭與髌白形成髌關節，股骨下端與髌骨形成關節。股骨的連續性受到破壞稱為股骨骨折。

（二）症狀

1. 疼痛、壓痛、腫脹。
2. 無法自然移動。
3. 移動斷骨時，可聽見捻髮聲。
4. 患肢血循受阻或瘀血、造成皮膚顏色的改變。
5. 出血。
6. 患肢畸形。
7. 患側與健側長短不一。

主題名稱	股骨骨折	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-G01	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	2/9

(三) 常見檢查

1. X 光攝影(X-ray)。
2. 電腦斷層攝影(Computerized Tomography；CT)。

(四) 常見治療

1. 復位

(1)閉鎖式復位(close reduction)：由醫師徒手復位使骨端對位，藉 X 光確定無誤後再予以制動（如：石膏固定）。

(2)開放性復位裝置內固定器(open reduction internal fixation；ORIF)：開放性復位及內固定術是以手術方式固定斷裂移位的骨頭，此手術是適合無法以石膏或夾板固定斷骨的病人。會放入植入物（例如：金屬骨釘、骨板、髓內釘連接桿或骨針）以固定斷骨及協助痊癒，植入物可能需要在骨折痊癒後移除。

2.牽引(traction)：有助於骨折的復位及休息，治療骨折提供肢體固定，減輕肌肉痙攣造成的疼痛及促進舒適。矯正、減緩或預防關節的畸形，以維持正常排列、促進癒合。

3.藥物治療：開放性骨折需依醫囑給予抗生素，以減輕或預防感染。

4.石膏支架：使用石膏支架後，可讓病人出院，並儘早開始復健治療。

5.截肢：嚴重骨折有時需做截肢手術。粉碎性骨折傷及關節與神經血管，當骨頭受到撞擊破裂時，周圍的肌肉、韌帶、血管、神經遭受很大的壓力，肌肉會形成腫脹期，尤其在 72 小時內肌肉會慢慢腫脹，造成血液無法流通，形成腔室症候群，影響血流血管受阻及神經傳導，若太嚴重則需進行壞死部分截肢。

(五) 護理問題

1. 疼痛不適／手術傷口。
2. 易感染／手術傷口。
3. 身體活動能力異常／疼痛。

主題名稱	股骨骨折	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-G01	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	3/9

(六) 護理措施

1. 疼痛不適／手術傷口有關

- (1)鼓勵病人說出疼痛的感受。
- (2)評估疼痛加劇的原因。
- (3)與病人及家屬共同討論引發疼痛的因素。
- (4)維持骨折部位的制動，並提供適當的支托（如枕頭），採舒適臥位。
- (5)教導放鬆技巧如：深呼吸、背部按摩、冥想。
- (6)予轉移注意力如：音樂、書籍、聊天。
- (7)適當肢體按摩放鬆，避免壓迫傷口處。
- (8)在病人選擇疼痛控制方法時，給予支持與指導。
- (9)依醫囑予物理治療如：冰敷。
- (10)搬動肢體時，動作要輕柔，避免不必要的外力。
- (11)依醫囑給予止痛劑，並評估病人對解除疼痛方法的反應。
- (12)每班紀錄疼痛性質、發生時間、持續時間及疼痛程度。

2. 易感染／手術傷口有關

- (1)治療前後洗手。
- (2)監測生命徵、監測全血球計數(CBC)並報告 WBC 異常現象。
- (3)依醫囑以無菌技術傷口換藥。
- (4)觀察傷口敷料外觀，每日評估傷口有無發紅、滲出液及壓痛等現象。
- (5)監測傷口引流：於最初 24-48 小時內，引流量應漸漸減少。
- (6)評估是否有感染症狀及徵象。
- (7)記錄及檢查傷口滲出液顏色、氣味、濃稠度、癒合情況。
- (8)依醫囑正確使用冰敷。
- (9)依醫囑按時給予抗生素。
- (10)教導保持傷口乾燥及清潔且避免壓迫傷口，並協助、教導翻身方式以避免壓迫傷口。

主題名稱	股骨骨折	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-G01	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	4/9

(11)教導抬高腿部，以促進靜脈血回流。

(12)鼓勵病人攝取高蛋白質與高維生素的食物，以促進傷口癒合。

(13)教導注意水份攝取及纖維素的攝取，以防發生便秘、泌尿道感染或形成結石。

(14)教導炎症症狀及徵象、感染的危險因子及預防感染的方法。

(15)教導選擇高蛋白、高維生素飲食，以促進傷口的修復再生。

(16)記錄引流管量、顏色、性質，並教導引流管照護方式與注意事項。

3. 身體活動能力異常／疼痛

(1)建議漸進式活動，教導並示範移動技巧，減輕移動時所引起的疼痛。

(2)教導及鼓勵病人每日執行關節運動，患肢肌肉作等長運動（足部背屈、臀肌、股四頭肌的等長運動），其他部位可作等張運動、膝關節屈曲、伸展，以預防攣縮。

(3)教導並提供疼痛控制以維持骨骼和肌肉最佳活動度。

(4)建議睡前背部按摩以促進舒適度。

(5)提供急性患肢關節休息和支托，以降低關節壓力和增加肌肉鬆弛。

(6)依醫囑予骨骼肌鬆弛劑。

(7)依醫囑使用固定器或夾板固定關節不動可減輕疼痛，並避免無功能姿勢的攣縮。

(8)平衡休息治療與主動身體運動計劃以增進體力及功能。

(9)協助並教導正確使用輔助器，並注意活動安全。

(10)可下床活動時，採漸進式活動。

（七）衛教指導

1. 傷口護理，保持傷口清潔乾燥。

2. 拐杖或助行器的使用，復健運動需持續，手術後 3 個月需使用拐杖。

3. 外固定器的照護:注意患肢有無麻木感、肢端是否可活動、肢體末端手指或腳趾溫暖且呈粉紅色；隨時保持傷口及周圍皮膚清潔和乾燥；常保持患肢抬高

主題名稱	股骨骨折	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-G01	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	5/9

的姿勢，以減輕肢體腫脹及疼痛；不可任意扭轉骨外固定器的螺絲或左右搖動鋼釘；勿將其他物品放置於骨外固定器上，並避免碰撞。

4. 飲食衛教：選擇高蛋白高維生素飲食，並攝取足夠鈣質，以促進骨骼癒合。

（八）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

（略）

五、流程圖

（略）

六、參考資料

- （一） 蔡安茹、李劉滢滢、王金蓮（2021）．照顧一位反覆跌倒股骨頸骨折病人之護理經驗．*榮總護理*，38(2)，143-149。

[https://doi.org/10.6142/VGHN.202106_38\(2\).0004](https://doi.org/10.6142/VGHN.202106_38(2).0004)

- （二） 吳秀玲、陶阿倫(2020)．住院病人止痛滿意度調查．*醫院雜誌*，53(1)，21-28。

- （三） 劉月純、吳香勳（2023）．運用長照資源協助一位股骨骨折獨居病人返家之護理經驗．*榮總護理*，40(3)，248-254。

[https://doi.org/10.6142/VGHN.202309_40\(3\).0003](https://doi.org/10.6142/VGHN.202309_40(3).0003)

- （四） 袁素娟、馮容芬、李惠玲（2024）．肌肉骨骼系統疾病之護理．於劉雪娥總校閱，*成人內外科護理*（第9版，下冊，第17章）．台北：華杏。

- （五） Cline, J. A., Nolte, J. A., Mendez, G. M., Willis, J. T., Bachinskas, A. J., Bengé, C. L., & Dart, B. R. (2021). Creating and Implementing a Protocol for the Management of Patients in Skeletal Traction: A Quality Improvement Project. *Kansas Journal of Medicine*, 14(3), 240-242. <https://doi.org/10.17161/kjm.vol14.15179>

主題名稱	股骨骨折	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-G01	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	6/9

- (六) Daunaraite, K., Uvarovas, V., Ulevicius, D., Sveikata, T., Petryla, G., Kurtinaitis, J., & Satkauskas, I. (2021). Reciprocal hematogenous osteomyelitis of the femurs caused by *Anaerococcus prevotii*: A case report. *World Journal of Clinical Cases*, 9(4), 830–837. <https://doi.org/10.12998/wjcc.v9.i4.830>
- (七) Gao, J., Liu, X., Wu, X., Li, M., Liu, X., & Li, M. (2023). A brief review and clinical evidences of teriparatide therapy for atypical femoral fractures associated with long-term bisphosphonate treatment. *Frontiers in Surgery*, 9, 1063170. <https://doi.org/10.3389/fsurg.2022.1063170>

七、附件

(略)

主題名稱	股骨骨折	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-G01	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	7/9

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
97.05.31	1.0	新制定	97 年 05 月 31 日護理部照護標準委員會通過
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版	
100.08.31	2.1	修改目的	100 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
101.08.31	2.2	內容檢閱並修改錯字	101 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
102.02.08	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱	
103.06.30	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.08.31.	3.1	增修第六項參考文獻資料	104 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
105.02.02	3.2	新增參考文獻出處於內文中	105 年 02 月 02 日護理部照護標準委員會通過
105.08.31	3.3	更新第六項參考文獻資料	105 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
106.08.31	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.29	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.09.12	3.4	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第一目；第二目之 1、6、7；第四目之 3、4；第六目之 3(10)；第七目之 4 參考資料修訂。 3. 第三項第六目之 1(7)(12)；之 2(16)新增說明。 4. 第六項第一目新增參考資料。	107 年 09 月 12 日護理長會議通過

主題名稱	股骨骨折	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-G01	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	8/9

修正日期	版本	修正說明	備註
108.09.23	3.5	1. 第三項第四目治療新增內容及參考資料。 2. 第三項第七目衛教指導外固定器照護新增說明及參考資料。 3. 第三項第八日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。 4. 新增第六項參考資料。	108 年 09 月 11 日護理長會議通過;108 年 09 月 23 日督導會議通過公布。
109.08.18	3.6	1. 第三項第四、六目治療新增內容及參考資料。 2. 第六項參考資料修訂。	109 年 08 月 06 日照護標準組會議通過; 109 年 08 月 12 日護理長會議通過;109 年 08 月 18 日督導會議通過公布。
110.08.05	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.09.06	3.7	1. 第三項第五目之護理問題：(1)疼痛改疼痛不適。(2)危險性感染改易感染。(3)身體活動功能障礙改身體活動能力異常。 2. 內文參考文獻引用刪除。	111 年 08 月 04 日照護標準組會議通過; 111 年 08 月 10 日護理長會議通過;111 年 09 月 06 日督導會議通過公布。
112.09.05	3.8	刪除年限較久之第六項參考資料。	112 年 08 月 03 日照護標準組會議通過; 112 年 08 月 09 日護理長會議通過;112 年 09 月 05 日督導會議通過公布。
113.09.03	3.9	第三項第四目之 1.(1)說明內容字詞修正。	113 年 08 月 08 日照護標準組會議通過; 113 年 08 月 14 日護理長會議通過;113 年 09 月 03 日督導會議通過公布。
114.10.08	4.0	修訂第六項參考文獻資料。	114 年 08 月 07 日照護標準組會議通過; 114 年 09 月 10 日護理長會議通過;114 年

主題名稱	股骨骨折	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-G01	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	9/9

修正日期	版本	修正說明	備註
			10 月 08 日督導會議 通過公布。